

Ramowy Plan Wdrożenia Innowacji

Terapeuta przestrzeni

Autorka innowacji: Urszula Żmudzińska

1. Istota innowacji:

Innowacja „Terapeuta przestrzeni - dostosowanie środowiska do indywidualnych potrzeb osób starszych” to pakiet usług realizowanych w miejscu zamieszkania seniora obejmujący: specjalistyczną diagnozę, plan ergonomizacji, szkolenia dla seniora i rodziny oraz wsparcie psychologiczne. Model zakłada **dostosowanie przestrzeni domowej seniora do jego indywidualnych dysfunkcji**, a jego kluczowym elementem jest maksymalne wykorzystanie zasobów, które senior już posiada (mebli, wyposażenia, układu lokalu), aby przedłużyć jego samodzielność w środowisku domowym.

Usługę realizuje trzysobowy zespół: terapeuta przestrzeni, fizjoterapeuta i psycholog. Każdy z nich wnosi odmienną, komplementarną perspektywę, dzięki czemu diagnoza i zmiany w mieszkaniu seniora są jednocześnie bezpieczne, funkcjonalne i akceptowalne psychologicznie.

Terapeuta przestrzeni - odpowiada za ocenę środowiska domowego i zaplanowanie ergonomicznych zmian wspierających codzienne funkcjonowanie seniora. łączy wiedzę z zakresu terapii zajęciowej, ergonomii, procesów starzenia oraz funkcjonowania społecznego. Rozpoznaje potrzeby bio-psycho-społeczne, tworzy indywidualny plan interwencji i uczy korzystania ze sprzętu wspomagającego.

Fizjoterapeuta - skupia się na utrzymaniu i poprawie sprawności seniora, aby umożliwić mu jak najdłuższą samodzielność. Przeprowadza testy funkcjonalne (np. TUG), opracowuje program treningu zdrowotnego i dobiera sprzęt wspierający bezpieczne poruszanie się.

Psycholog - diagnozuje stan psychiczny seniora, wspiera w adaptacji do zmian w otoczeniu i prowadzi psychoedukację rodziny.

2. Kluczowe wyróżniki rozwiązania

- **Wykorzystanie własnych zasobów:** Model nie opiera się na kosztownych remontach, lecz na kreatywnym i niskokosztowym wykorzystaniu istniejącego wyposażenia mieszkania.
- **Holistyczne podejście:** Łączy elementy ergonomii, fizjoterapii i wsparcia psychologicznego w jednym, spójnym procesie realizowanym w miejscu zamieszkania seniora.
- **Wzmacnianie sprawczości:** Senior nie jest biernym odbiorcą pomocy, lecz aktywnym współtwórcą zmian – każda modyfikacja wymaga jego akceptacji.
- **Wsparcie dla opiekunów:** Zamiast obciążać rodzinę, oferuje krótkie, praktyczne szkolenia i narzędzia dostosowane do ich ograniczonych możliwości czasowych.

3. Diagnoza: na jaki problem/potrzebę odpowiada innowacja?

- **Niefunkcjonalność mieszkań:** Spadek sprawności osób w wieku senioralnym sprawia, że dotychczasowe lokum staje się niebezpieczne (wysokie progi, ryzykowne elementy łazienki), co przyspiesza decyzję o umieszczeniu w placówce całodobowej opieki (np. DPS).
- **Starzenie się społeczeństwa:** W Małopolsce w 2024 r. osoby 60+ stanowiły aż 24,5% populacji, a liczba osób powyżej 80 lat (wymagających skokowo większej pomocy) stale rośnie¹.
- **Bariera w systemie opieki:** Braki kadrowe wśród opiekunów oraz zapracowanie młodszych pokoleń powodują, że seniorzy zostają sami ze swoimi ograniczeniami.
- **Skutki izolacji:** Poczucie bycia ciężarem dla bliskich i lęk przed upadkiem prowadzą do wycofania społecznego i drastycznego spadku jakości życia.

4. Model Innowacji: Co konkretnie wdrażasz?

Innowacja dostarcza kompletny pakiet narzędzi wdrożeniowych na otwartej licencji:

- **Model merytoryczny,** czyli opis metodyki „Terapeuta przestrzeni – dostosowanie środowiska do indywidualnych potrzeb osób starszych”.
- **Scenariusze treningowe** - gotowe instrukcje prowadzenia warsztatów dla osób zależnych oraz ich rodzin metodą „uczenia przez doświadczanie”.

¹ Dane Głównego Urzędu Statystycznego.

- **Narzędzia diagnostyczne**, takie jak kwestionariusze wywiadu, testy czynnościowe (np. test „Wstań i Idź”) oraz wzory rekomendacji psychologicznych.
- **Dokumentacja operacyjna**, w tym wzory planów ergonomizacji przestrzeni, protokoły interwencji i karty konsultacji.

5. Lekcje z testowania: Jak uniknąć pułapek?

Testowanie innowacji „Terapeuta przestrzeni” opierało się na **wielospecjalistycznym wsparciu seniorów bezpośrednio w ich miejscu zamieszkania**, co pozwoliło na realną ocenę ich codziennych trudności. Proces ten składał się z trzech kluczowych etapów: diagnozowania, wdrażania zmian ergonomicznych oraz szkoleń dla seniorów i ich rodzin. Wnioski płynące z testów to:

- **Bariera w szukaniu pomocy:** Seniorzy często uważają, że muszą radzić sobie sami, w związku z czym często nie szukają specjalistycznego wsparcia pomimo problemów zdrowotnych. Kluczem jest empatyczne podejście i budowanie zaufania.
- **Specyfika wizyt domowych:** Należy założyć elastyczny czas pracy - seniorzy często bardziej potrzebują rozmowy i ugoszczenia specjalisty niż szybkiej realizacji zadań.
- **Prostota rozwiązań:** Rekomendowane zmiany muszą być maksymalnie proste, aby seniorzy mogli je bezpiecznie stosować po wyjściu specjalisty. Najlepiej sprawdzają się rozwiązania niskokosztowe, wykorzystujące posiadane już przez seniora zasoby.
- **Praca nad motywacją i akceptacją:** Zaobserwowano znikomą motywację do zmian oraz trudności w utrwalaniu przekazywanych treści, co wymaga włączenia treningów typu „Insight” oraz stałego wsparcia psychologa.
- **Zaangażowanie rodziny:** Dużym wyzwaniem okazało się włączenie członków rodziny w proces szkoleniowy, co tłumaczono głównie brakiem czasu i pracą zawodową.

6. Matryca logiczna



Problem

Utrata samodzielności seniorów w niefunkcjonalnych mieszkaniach, prowadząca do ich izolacji i instytucjonalizacji wsparcia.



Rozwiązanie

Model wielospecjalistycznego wsparcia w domu (fizjoterapia, psychologia) mające na celu ergonomizację przestrzeni i naukę bezpiecznego funkcjonowania.



Cel główny

Odejście od tradycyjnego, opiekuńczego modelu wsparcia seniorów na rzecz podejścia, które wzmacnia ich sprawczość oraz wykorzystuje potencjał środowiska domowego.

7. Strategia Komunikacji i BIG IDEA

Komunikacja powinna wskazywać, że **środowisko domowe seniora może stać się bezpiecznym azylem**, które nie jest przeciwko niemu, a działa na jego rzecz:

„Mój dom – moje bezpieczne miejsce”.

- **Filary przekazu:** Edukacja o wpływie drobnych zmian na zdrowie i jakość codziennego funkcjonowania, rola rodziny w adaptacji, profesjonalizacja Terapeuty Przestrzeni jako eksperta.
- **Ton:** Wspierający, ekspercki, ale przystępny, skupiony na bezpieczeństwie i komforcie.
- **Grupy docelowe:** Seniorzy 60+, ich rodziny (często zapracowane dzieci), instytucje pomocy społecznej (OPS/CUS), sektor pozarządowy.

8. Potencjał rozwoju i inspiracje

Wnioskodawcy mogą rozwijać model w zależności od diagnozy i specyficznych potrzeb lokalnego środowiska:

- **Skalowalność:** Model można wdrożyć zarówno w pojedynczej gminie, jak i jako system regionalny.
- **Integracja usług:** Możliwość połączenia z istniejącymi strukturami wsparcia, takimi jak środowiskowe domy samopomocy, kluby seniora, centra usług społecznych czy zespoły

opieki domowej - albo jako samodzielna, mobilna usługa realizowana przez przeszkolonych terapeutów przestrzeni.

- **Mobilność:** Usługa idealnie sprawdza się na terenach wiejskich i o rozproszonej zabudowie, gdzie dostęp do stacjonarnej opieki jest utrudniony.

9. Podsumowanie korzyści dla realizatora (np. Gminy/OPS/CUS):

Wdrożenie „Terapeuty przestrzeni” pozwala samorządom na **znaczące oszczędności** poprzez odroczenie konieczności umieszczania seniorów w kosztownych placówkach całodobowych (DPS).

Dzięki **gotowej dokumentacji i wzorom narzędzi**, realizator otrzymuje produkt „pod klucz”, który buduje nowoczesny wizerunek lokalnej polityki senioralnej opartej na usługach środowiskowych i realnym wsparciu opiekunów faktycznych.

Dzięki innowacji seniorzy zyskują większą samodzielność, bezpieczeństwo i sprawność dzięki ergonomizacji mieszkania, treningom zdrowotnym oraz wsparciu emocjonalnemu, co przekłada się na lepszy dobrostan i większą aktywność społeczną. Rodziny otrzymują rzetelną wiedzę, wskazówki dotyczące opieki i wsparcie psychologiczne, co ułatwia im zrozumienie potrzeb bliskiej osoby i poprawia relacje.

Terapeuta przestrzeni

1. Istota innowacji – czego nie można zgubić

“Terapeuta przestrzeni” nie jest remontem mieszkania, zakupem uchwytów ani jednorazową wizytą specjalisty. To domowa usługa wspierająca seniora w dłuższym zachowaniu samodzielności przez dopasowanie mieszkania do jego realnych ograniczeń, nawyków, lęków i możliwości.

Istotą innowacji jest diagnoza mieszkania i codziennego funkcjonowania seniora, a następnie wprowadzenie prostych, niskokosztowych zmian z wykorzystaniem tego, co senior już ma: mebli, układu pomieszczeń, sprzętów i codziennych rutyn. Model obejmuje diagnozę, plan ergonomizacji, trening seniora i rodziny oraz wsparcie psychologiczne.

Usługa realizowana jest przez trzyosobowy zespół specjalistów, którzy patrzą na funkcjonowanie seniora z różnych, uzupełniających się perspektyw:

- terapeuta przestrzeni odpowiada za ocenę środowiska domowego, identyfikację barier oraz zaplanowanie zmian wspierających codzienne funkcjonowanie seniora; łączy wiedzę z zakresu ergonomii, terapii zajęciowej, procesów starzenia i funkcjonowania społecznego;
- fizjoterapeuta ocenia sprawność seniora, bezpieczeństwo poruszania się oraz ryzyko upadków, a następnie proponuje ćwiczenia, trening funkcjonalny i rozwiązania wspierające samodzielność;
- psycholog wspiera seniora i rodzinę w adaptacji do zmian, pomaga oswoić lęk przed utratą sprawności oraz wzmacnia gotowość do korzystania z nowych rozwiązań i codziennych nawyków.

Tego nie należy pomijać:

- usługa musi odbywać się w mieszkaniu seniora, bo dopiero tam widać realne ryzyka;
- senior ma być współtwórcą zmian, nie biernym odbiorcą zaleceń;
- rozwiązania mają być proste, bezpieczne i możliwe do utrzymania po wyjściu specjalisty;
- celem nie jest "ładniejsze mieszkanie", tylko bezpieczniejsze codzienne funkcjonowanie;
- usługa łączy ergonomię, fizjoterapię, psychologię i edukację rodziny - nie jest wyłącznie techniczną adaptacją lokalu;

- rekomendacje muszą uwzględniać realne możliwości finansowe seniora i rodziny - usługa nie może kończyć się listą kosztownych zakupów lub remontów.

Ważne ostrzeżenie dla podmiotu wdrażającego:

Nie należy przekształcać tej innowacji w program remontowy lub zakupowy. Jeżeli usługa zostanie sprowadzona wyłącznie do montażu uchwytów, zakupu sprzętu lub wymiany wyposażenia, zniknie jej najważniejszy element: wspólna praca nad zmianą sposobu funkcjonowania seniora w jego własnym domu i wzmacnianiem jego możliwie najdłuższej samodzielności.

2. Jak przekształcić innowację w usługę społeczną

Innowacja Terapeuta przestrzeni może być bardzo praktyczną usługą środowiskową, bo odpowiada na problem, który OPS/CUS widzi codziennie: senior jeszcze mieszka sam, ale coraz gorzej radzi sobie z samoobsługą, schodami, progiem, kuchnią, łóżkiem, oświetleniem, lękiem przed upadkiem i poczuciem, że staje się ciężarem dla rodziny.

Usługa powinna działać jako domowy audyt samodzielności i bezpieczeństwa, zakończony prostym planem zmian:

- wnioskodawca identyfikuje seniorów zagrożonych utratą samodzielności;
- zespół specjalistów odwiedza seniora w domu;
- obserwują, jak senior wstaje, chodzi, korzysta z łazienki, kuchni, łóżka i krzesła;
- wykonują krótkie testy funkcjonalne;
- rozmawiają z seniorem i rodziną;
- przygotowują plan ergonomizacji przestrzeni;
- pomagają wdrożyć najprostsze zmiany;
- uczą seniora i rodzinę nowych sposobów bezpiecznego funkcjonowania;
- wracają po pewnym czasie, żeby sprawdzić, co działa.

Usługa powinna być przedstawiana jako:

- wsparcie dla samodzielności seniora;
- praktyczna pomoc dla rodzin;
- profilaktyka upadków i utraty sprawności;
- nowoczesna usługa środowiskowa dostępna dla mieszkańców, a nie wyłącznie dla osób korzystających z pomocy społecznej.

Warto rozważyć możliwość korzystania z usługi niezależnie od dochodu, szczególnie jeśli gmina chce budować bardziej uniwersalny model usług społecznych, a nie wyłącznie interwencję socjalną.

3. Mapa wdrożenia usługi - krok po kroku

Etap przygotowania usługi - do 6 miesięcy

1) Przygotować lokalny model realizacji usługi

Na początku warto jasno określić role osób zaangażowanych we wdrożenie oraz sposób współpracy między specjalistami, rodziną i podmiotem realizującym usługę.

Praktyczny podział:

- podmiot wdrażający organizuje proces, kontakt z rodziną oraz harmonogram działań;
- terapeuta przestrzeni, fizjoterapeuta lub odpowiednio przygotowany pracownik przeprowadza diagnozę funkcjonalną mieszkania i codziennego funkcjonowania seniora;
- psycholog wspiera seniora i rodzinę w akceptacji zmian oraz adaptacji do nowych sposobów funkcjonowania;
- pracownik socjalny, opiekunka środowiskowa lub inna osoba pracująca w środowisku lokalnym może wspierać monitorowanie wdrażanych zmian;
- rodzina uczestniczy w instruktażu i uczy się, jak wspierać seniora w codziennym funkcjonowaniu;
- lokalni wykonawcy lub rzemieślnicy mogą pomagać przy prostych adaptacjach mieszkania.

W praktyce nie zawsze konieczne jest budowanie nowego zespołu specjalistów od podstaw.

Możliwe jest również przygotowanie pracowników podmiotu wdrażającego do wykonywania części diagnozy i wdrażania zmian poprzez szkolenia, konsultacje i pracę z gotowymi narzędziami innowacji.

Warto od początku rozwijać lokalną sieć współpracy obejmującą między innymi:

- drobnych wykonawców;
- stolarzy i osoby wykonujące proste adaptacje mieszkań;
- szkoły branżowe;
- lokalnych przedsiębiorców;
- uczelnie zajmujące się architekturą, wzornictwem lub projektowaniem uniwersalnym.

Dzięki temu usługa może stopniowo budować lokalne kompetencje związane z dostosowywaniem mieszkań do potrzeb osób starszych i wspieraniem ich możliwie najdłuższej samodzielności w miejscu zamieszkania.

2) Wybrać grupę seniorów

Na początku nie warto tworzyć szerokiej akcji skierowanej do wszystkich seniorów. Lepiej skoncentrować usługę na osobach, u których stosunkowo niewielkie zmiany w mieszkaniu i codziennych nawykach mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz ograniczyć ryzyko utraty samodzielności.

Przy kwalifikowaniu uczestników warto opierać się na ocenie poziomu samodzielności seniora, między innymi z wykorzystaniem Skali Barthel oraz obserwacji codziennego funkcjonowania w domu.

Szczególną uwagę warto zwrócić na:

- seniorów mieszkających samotnie;
- osoby po upadkach lub odczuwające lęk przed upadkiem;
- osoby po hospitalizacji lub pogorszeniu sprawności;
- seniorów mających trudności z korzystaniem z łazienki, łóżka, kuchni lub schodów;
- osoby z ograniczoną mobilnością;
- sytuacje, w których rodzina lub opiekunowie obserwują narastające trudności w codziennym funkcjonowaniu;
- seniorów zagrożonych koniecznością zwiększenia zakresu usług opiekuńczych lub skierowania do opieki instytucjonalnej.

W praktyce bardzo skutecznym źródłem zgłoszeń mogą być:

- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej;
- pielęgniarki środowiskowe;
- fizjoterapeuci i rehabilitanci;
- pracownicy socjalni i opiekunki środowiskowe;
- kluby seniora;
- organizacje lokalne i parafie;
- rodziny wielopokoleniowe;
- osoby mające regularny kontakt z seniorami w środowisku lokalnym.

Seniorzy często nie reagują na ogólne kampanie informacyjne lub oficjalne komunikaty. Znacznie skuteczniejsze jest docieranie do nich przez osoby, którym ufają i które znają ich codzienne trudności.

3) Przygotować prostą procedurę kwalifikacji

Kwalifikacja do usługi powinna obejmować zarówno ocenę poziomu samodzielności seniora, jak i analizę tego, w jaki sposób warunki mieszkaniowe wpływają na jego codzienne funkcjonowanie.

W praktyce warto uwzględnić:

- ocenę samodzielności seniora;
- krótki opis najważniejszych trudności w codziennym funkcjonowaniu;
- informację, czy senior mieszka sam;
- historię upadków lub innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu;
- zakres wsparcia ze strony rodziny lub opiekunów;
- gotowość seniora do przyjęcia wizyty i współpracy przy zmianach;
- zgodę na wejście do mieszkania i przeprowadzenie diagnozy;
- ocenę, czy trudności wynikają przede wszystkim z organizacji przestrzeni i sposobu funkcjonowania w domu, a nie wyłącznie z potrzeby dużego remontu lub modernizacji mieszkania.

Na tym etapie bardzo ważna jest także odpowiednia komunikacja z seniorem i rodziną. Warto jasno podkreślać, że:

- usługa nie ma charakteru kontroli;
- nie służy ocenie “czy senior sobie radzi”;
- jej celem nie jest ograniczanie samodzielności;
- działania mają pomóc seniorowi bezpieczniej i bardziej komfortowo funkcjonować we własnym domu możliwie jak najdłużej.

4) Przygotować narzędzia pracy

Opis innowacji wskazuje gotowy pakiet: model merytoryczny, scenariusze treningowe, kwestionariusze wywiadu, testy czynnościowe, wzory rekomendacji psychologicznych, plany ergonomizacji, protokoły interwencji i karty konsultacji.

Podmiot wdrażający nie musi tworzyć całej dokumentacji od początku. W praktyce warto wybrać prosty zestaw narzędzi, który ułatwi diagnozę, planowanie zmian i monitorowanie efektów usługi.

Minimalny zestaw może obejmować:

- kartę zgłoszenia seniora;
- kartę wizyty domowej;
- listę ryzyk i barier w mieszkaniu;
- plan ergonomizacji przestrzeni;
- kartę zaleceń dla seniora i rodziny;
- kartę wizyty kontrolnej;
- kartę rekomendacji psychologicznych lub funkcjonalnych.

Warto również uzupełnić standard o:

- orientacyjny poziom kosztów proponowanych zmian;
- podział rekomendacji na: działania możliwe do wykonania samodzielnie, drobne zakupy poprawiające bezpieczeństwo, zmiany wymagające wsparcia wykonawcy lub specjalisty;
- wskazanie priorytetów: co warto wdrożyć najpierw, aby szybko ograniczyć najważniejsze ryzyka.

To bardzo ważne, aby senior i rodzina nie kończyli wizyty z poczuciem konieczności kosztownego remontu lub całkowitej reorganizacji mieszkania. Istotą usługi jest pokazanie, że nawet niewielkie, dobrze przemyślane zmiany mogą realnie poprawić bezpieczeństwo i komfort codziennego funkcjonowania.

5) Zbudować mały zespół kompetencji

Nie potrzeba dużego zespołu. Minimum:

- osoba z OPS/CUS do kontaktu;
- specjalista od funkcjonowania ruchowego;
- psycholog;
- kontakt do drobnego wykonawcy, jeśli trzeba coś przestawić, zamontować lub usunąć.

Dobłą praktyką może być stworzenie:

- lokalnej "podzielni" sprzętów i prostych rozwiązań;
- bazy wymiany używanych elementów wyposażenia;
- sieci lokalnych rzemieślników wspierających seniorów w drobnych dostosowaniach mieszkań.

6) Przygotować standard pierwszej wizyty

Testowanie pokazało, że wizyty domowe wymagają elastycznego czasu, bo seniorzy często bardziej potrzebują rozmowy i budowania zaufania niż szybkiej realizacji zadań.

Pierwsza wizyta powinna obejmować:

- rozmowę wprowadzającą;
- obserwację codziennych czynności;
- ocenę łazienki, kuchni, sypialni, przejść i oświetlenia;
- krótkie testy sprawności;
- ustalenie, czego senior się boi;
- wybór 3-5 najważniejszych zmian, nie 30 zaleceń;
- wskazanie prostych działań możliwych do wykonania od razu.

Warto unikać sytuacji, w której senior po wizycie otrzymuje długą listę problemów bez realnego wsparcia we wdrożeniu zmian.

7) Przygotować język komunikacji

Nie mówić seniorowi:

- "mieszkanie jest niebezpieczne",
- "trzeba to zmienić",
- "OPS przyjdzie ocenić sytuację".

Lepszy komunikat:

- "Sprawdzimy, co można zrobić, żeby było Pani/Panu łatwiej."
- "Nie będziemy robić remontu, tylko poszukamy prostych zmian."
- "To Pan/Pani decyduje, które rozwiązania są do przyjęcia."
- "Celem jest, żeby jak najdłużej dobrze funkcjonować u siebie."
- "To praktyczna pomoc dla seniora i rodziny, a nie kontrola mieszkania."

Warto wykorzystać pozytywną narrację podobną do tej zaproponowanej przez twórców innowacji:

"Mój dom - moje bezpieczne miejsce".

Etap świadczenia usługi - minimum 12 miesięcy

Rytm usługi:

- zgłoszenie seniora;

- kwalifikacja do udziału w usłudze;
- pierwsza wizyta domowa;
- diagnoza funkcjonalna, przestrzenna i psychologiczna;
- przygotowanie planu ergonomizacji mieszkania;
- wdrożenie prostych zmian poprawiających bezpieczeństwo i codzienne funkcjonowanie;
- trening seniora dotyczący bezpiecznego korzystania z przestrzeni;
- konsultacje psychologiczne wspierające adaptację do zmian i wzmacniające poczucie sprawczości seniora;
- krótki instruktaż dla rodziny lub opiekuna;
- wizyta kontrolna;
- korekta zaleceń i dalszych działań;
- decyzja o potrzebie dodatkowego wsparcia, np. rehabilitacji, teleopieki, pomocy sąsiedzkiej, usług środowiskowych lub drobnego doposażenia mieszkania.

4. Co jest obowiązkowe, a co można rozszerzać

Elementy konieczne

Bez tych elementów usługa przestaje być "Terapeutą przestrzeni":

- wizyta w miejscu zamieszkania seniora;
- diagnoza codziennych czynności i poziomu samodzielności;
- analiza przestrzeni i identyfikacja ryzyk w mieszkaniu;
- przygotowanie planu prostych zmian poprawiających bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania;
- konsultacja psychologiczna wspierająca akceptację zmian i adaptację seniora;
- akceptacja proponowanych rozwiązań przez seniora;
- trening bezpiecznego korzystania z przestrzeni i codziennych czynności;
- włączenie rodziny lub opiekuna w proces wsparcia;
- wizyta kontrolna;
- dokumentowanie efektów usługi;
- rekomendacje możliwe do wdrożenia przy realnych możliwościach finansowych seniora i rodziny.

Elementy opcjonalne

Możliwe rozszerzenia:

- baza wymiany sprzętów i wyposażenia;
- lokalna sieć rzemieślników wspierających drobne adaptacje mieszkań;
- współpraca z uczelniami architektonicznymi, artystycznymi i technicznymi;
- bank prostych rozwiązań typu "zrób to sam";
- drobne doposażenie poprawiające bezpieczeństwo i ergonomię mieszkania;
- teleopieka;
- wolontariat sąsiedzki;
- współpraca z podstawową opieką zdrowotną i rehabilitacją;
- szkolenia i instruktaże dla rodzin oraz opiekunów;
- współpraca z centrami aktywności seniorów, klubami seniora i lokalnymi organizacjami wspierającymi osoby starsze;
- działania pomagające ograniczać izolację społeczną seniorów;
- konsultacje psychologiczne dotyczące lęku przed wychodzeniem z domu, utratą sprawności lub zmianą codziennych nawyków;
- wspólne planowanie bezpiecznych tras codziennego funkcjonowania seniora, np. do sklepu, apteki, kościoła, przychodni lub na cmentarz;
- działania wspierające odbudowę codziennej aktywności i poczucia sprawczości seniora poza mieszkaniem.

5. Jak poradzić sobie z typowymi barierami JST

Bariera 1: "Instytucje społeczne kojarzą się z kontrolą"

To jedna z najważniejszych barier wdrożeniowych. W wielu środowiskach seniorzy nadal kojarzą kontakt z pomocą społeczną głównie z sytuacją kryzysową, oceną sytuacji życiowej lub utratą samodzielności.

Dlatego:

- usługa powinna być komunikowana jako wsparcie codziennego bezpieczeństwa i samodzielności;
- warto angażować partnerów spoza systemu pomocy społecznej;
- nie opierać rekrutacji wyłącznie na formalnych procedurach i formularzach;

- korzystać z rekomendacji lekarzy, rodzin, pielęgniarek, opiekunów środowiskowych, sołtysów i organizacji lokalnych.

Bariera 2: "Seniorzy nie zgłaszają się sami"

To naturalna sytuacja. Wielu seniorów przez lata funkcjonowało w przekonaniu, że problemy należy rozwiązywać samodzielnie i nie prosić o pomoc.

Dlatego skuteczniejsze od ogólnych kampanii informacyjnych są osoby mające codzienny kontakt z seniorami, między innymi:

- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej;
- rehabilitanci i fizjoterapeuci;
- pielęgniarki środowiskowe;
- rodziny i sąsiedzi;
- sołtysi;
- kluby seniora;
- parafie i organizacje lokalne.

Bariera 3: "To skończy się kosztownym remontem"

Usługa nie powinna prowadzić do tworzenia listy drogich modernizacji lub całkowitej przebudowy mieszkania. Właśnie nie powinno. Jej celem jest przede wszystkim:

- wskazanie najważniejszych zmian poprawiających bezpieczeństwo;
- wykorzystanie istniejącego wyposażenia i układu mieszkania;
- proponowanie rozwiązań niskokosztowych;
- wybór działań możliwych do wykonania samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu;
- ograniczanie ryzyk w codziennym funkcjonowaniu seniora.

Bariera 4: "Nie mamy odpowiednich kadr"

Usługa nie wymaga tworzenia nowej instytucji ani dużego zespołu specjalistów zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu.

W praktyce skuteczniejsze może być:

- stworzenie małego zespołu współpracujących specjalistów;
- wykorzystanie istniejących lokalnie kompetencji;
- budowanie sieci współpracy między podmiotami;
- przygotowanie bazy specjalistów i wykonawców wspierających seniorów;

- przeszkolenie przedstawicieli istniejącej kadry w zakresie niezbędnym do wdrażania usługi i prowadzenia podstawowej diagnozy funkcjonalnej.

6. Działania wspierające wdrożenie innowacji

Rekomendowane działania:

- domowa karta bezpieczeństwa seniora;
- checklista ryzyk i barier w poszczególnych pomieszczeniach;
- instruktaż dla rodziny i opiekunów dotyczący bezpiecznego wspierania seniora;
- krótkie treningi codziennych czynności i bezpiecznego poruszania się po mieszkaniu;
- konsultacje psychologiczne wspierające adaptację do zmian i ograniczające lęk przed utratą samodzielności;
- telefon kontrolny po wdrożeniu zmian;
- wizyty kontrolne monitorujące funkcjonowanie seniora;
- bank drobnego sprzętu i prostych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo;
- baza wymiany lub ponownego wykorzystania wyposażenia wspierającego seniorów;
- sieć lokalnych rzemieślników pomagających przy drobnych adaptacjach mieszkań;
- współpraca z uczelniami architektonicznymi, artystycznymi i technicznymi;
- szkolenia dla osób pracujących w środowisku seniorów, np. opiekunek środowiskowych;
- współpraca z podstawową opieką zdrowotną, rehabilitacją i fizjoterapią;
- działania ograniczające izolację społeczną seniorów i wspierające ich aktywność poza mieszkaniem;
- współpraca z klubami seniora, centrami aktywności seniorów i organizacjami lokalnymi.

7. Jak wykorzystać wdrożenie do trwałej zmiany lokalnej

Po zakończeniu grantu mogą pozostać:

- lokalna procedura oceny bezpieczeństwa i funkcjonalności mieszkań seniorów;
- sieć lokalnych wykonawców i rzemieślników wspierających drobne adaptacje mieszkań;
- baza prostych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i ergonomię codziennego funkcjonowania;
- możliwość wymiany lub ponownego wykorzystania wyposażenia wspierającego seniorów;
- lepsza współpraca między podmiotami społecznymi, zdrowotnymi i środowiskowymi;
- bardziej wspierający i relacyjny sposób komunikowania usług kierowanych do seniorów;

- skuteczniejsze docieranie do osób samotnych i zagrożonych utratą samodzielności;
- większa wiedza o tym, jak niewielkie zmiany w mieszkaniu i codziennych nawykach mogą ograniczać ryzyko upadków, hospitalizacji i konieczności opieki całodobowej;
- przeszkolona kadra posiadająca kompetencje w zakresie oceny funkcjonalnej mieszkania i pracy środowiskowej z seniorem.

Najważniejsza zmiana myślenia:

Wsparcie seniora przestaje koncentrować się wyłącznie na reagowaniu na kryzys lub utratę samodzielności. Usługa pokazuje, że odpowiednio wcześniej wprowadzone, proste i możliwe do zaakceptowania zmiany mogą pomóc seniorowi dłużej, bezpieczniej i bardziej komfortowo funkcjonować we własnym domu, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów, relacji i codziennych nawyków.

8. Możliwe kierunki rozwoju usługi lokalnie

Po etapie pilotażowym usługa może być rozwijana w zależności od lokalnych potrzeb, dostępnych partnerstw i doświadczeń zdobytych podczas pracy z seniorami.

Możliwe kierunki rozwoju:

- stworzenie lokalnej bazy lub punktu wymiany wyposażenia wspierającego samodzielność seniorów;
- budowanie sieci lokalnych rzemieślników pomagających w drobnych adaptacjach mieszkań;
- współpraca z uczelniami architektonicznymi, artystycznymi i technicznymi w zakresie projektowania przyjaznych rozwiązań dla seniorów;
- połączenie usługi z teleopieką, usługami środowiskowymi i pomocą sąsiedzką;
- rozwój ścieżki wsparcia seniora po hospitalizacji lub pogorszeniu sprawności;
- włączenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitantów i fizjoterapeutów do systemu kierowania seniorów do usługi;
- tworzenie prostych katalogów i poradników „zrób to sam” dla rodzin i opiekunów;
- rozwój działań ograniczających izolację społeczną seniorów;
- współpraca z klubami seniora i centrami aktywności seniorów;
- rozwijanie lokalnych kompetencji w zakresie ergonomii mieszkań i projektowania przyjaznego starzenia;

- tworzenie modeli współpracy między podmiotami działającymi na rzecz seniorów w środowisku lokalnym.

9. Szybka checklista dla Grantobiorcy przed zaplanowaniem wdrożenia

- Czy zachowujemy istotę innowacji: domową diagnozę funkcjonowania seniora, plan prostych zmian oraz trening bezpiecznego korzystania z przestrzeni?
- Czy usługa realizowana jest w rzeczywistym miejscu zamieszkania seniora?
- Czy senior uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w mieszkaniu i codziennym funkcjonowaniu?
- Czy usługa nie została sprowadzona wyłącznie do remontu lub zakupu wyposażenia?
- Czy rekomendacje uwzględniają realne możliwości finansowe seniora i jego rodziny?
- Czy przewidziano wsparcie w pracy z lękiem, oporem lub trudnością w akceptacji zmian?
- Czy sposób komunikowania usługi buduje poczucie wsparcia i bezpieczeństwa, a nie kontroli?
- Czy wykorzystujemy lokalne kanały dotarcia do seniorów i osoby cieszące się ich zaufaniem?
- Czy możliwe jest korzystanie z lokalnych wykonawców, rzemieślników lub innych zasobów środowiskowych?
- Czy po zakończeniu grantu pozostanie lokalna sieć współpracy wspierająca seniorów w bezpiecznym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania?

TERAPEUTA PRZESTRZENI – W SKRÓCIE

INNOWACJA W POSTACI USŁUGI SPOŁECZNEJ



CO?

NA CZYM POLEGA?



Domowa usługa, która pomaga seniorowi bezpiecznie i samodzielnie funkcjonować w swoim domu.

Specjalista diagnozuje mieszkanie i codzienne nawyki, a następnie – wraz z seniorem i rodziną – wprowadza proste, niskokosztowe zmiany, uczy nowych sposobów funkcjonowania i wspiera w ich utrzymaniu.

KLUCZ:

- ✓ Wizyta w domu seniora
- ✓ Senior współtwórcą zmian
- ✓ Proste, możliwe do utrzymania rozwiązania
- ✓ Łączy ergonomię, fizjoterapię, psychologię i edukację
- ✓ Nie remontuje – zmienia sposób funkcjonowania



JAK?

ETAPY WDROŻENIA
USŁUGI

1

**IDENTYFIKACJA
I ZGŁOSZENIE**



OPS/CUS/inny podmiot i partnerzy lokalni identyfikują seniorów zagrożonych utratą samodzielności.



2

**WIZYTA
W DOMU**



Specjalista odwiedza seniora, obserwuje codzienne czynności, wykonuje krótkie testy funkcjonalne.



3

**DIAGNOZA
I PLAN**



Rozmowa z seniorem i rodziną, analiza ryzyk i zasobów. Plan prostych, realnych zmian w przestrzeni i nawykach.



4

**WDROŻENIE
I TRENING**



Wspólne wprowadzanie zmian, trening bezpiecznego funkcjonowania seniora i instruktaż dla rodziny.



5

**WIZYTA
KONTROLNA**



Sprawdzenie efektów, ewentualne korekty, utrwalanie dobrych nawyków.



PO CO?

GŁÓWNA KORZYŚĆ
DLA GMINY



Większe bezpieczeństwo seniorów w domu



Dłuższe utrzymanie samodzielności i lepsza jakość życia



Mniejsze obciążenie rodzin i opiekunów



Mniej kosztownych interwencji i pobyków w instytucjach



Aktywni, bezpieczni seniorzy i bardziej efektywny system usług w gminie



Małe zmiany w domu + nowe nawyki = więcej samodzielności, mniej ryzyka, niższe koszty dla gminy.



Szacunek i partnerstwo



Indywidualne potrzeby i decyzje seniora



Proste i realne rozwiązania



Współpraca lokalna i międzyinstytucjonalna



Trwałe efekty po zakończeniu projektu